



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

« _____ » _____

№ _____

м. Львів

**Про організацію протитуберкульозної
медичної допомоги у Львівській області**

На виконання Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1414-р «Про схвалення Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги», від 27.11.2019 №1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року», від 02.08.2024 № 726-р «Про схвалення стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки та затвердження Оперативного плану її реалізації», відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.2023 № 102 «Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами) та з метою забезпечення безперервного доступу до діагностики, лікування та профілактики туберкульозу серед населення Львівської області, -

НАКАЗУЮ :

1. Керівникам закладів охорони здоров'я Львівської області забезпечити:

1.1. Організацію та проведення всім амбулаторним та стаціонарним пацієнтам з кашлем, що триває понад 2 тижні скринінгового анкетування стосовно чинників ризику та симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз (ТБ) (Додаток 1), згідно додатку 8 Стандарту охорони здоров'я при ТБ, затвердженого наказом МОЗ України від 19.01.2023 № 102 «Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами).

1.2. Організацію та проведення обстеження на легеневий та/або позалегеневий ТБ із застосуванням загально-клінічних, мікробіологічних, радіологічних методів згідно з критеріями 3, 4, 5, 6, 7, 8, розділу III Стандарту охорони здоров'я при ТБ, затвердженого наказом МОЗ України від 19.01.2023 №102 «Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами) усіх осіб, які звернулись за медичною допомогою



Львівська ОДА
№22-269/04-14/25 від 05.06.2025
КЕП: ЛІТВІНСЬКА Н. С. 04.06.2025 18:17
5E984D526F82F38F04000000F0341F010A726C05

№22-269/04-14/25 від 05.06.2025

із симптомами та захворюваннями, за наявності яких пацієнту проводять обстеження на ТБ (Додаток 2), а також осіб із підозрою на ТБ за результатами систематичного скринінгу.

1.3. Скерування усіх осіб, які звернулись за медичною допомогою із симптомами та захворюваннями, за наявності яких пацієнту проводять обстеження на ТБ, відповідно регіональному маршруту пацієнта з підозрою на туберкульоз (далі – Маршрут пацієнта) (Додаток 3).

1.4. Обов'язковий збір мокротиння у пацієнтів з підозрою на ТБ легень, які продукують мокроту, та організацію транспортування зразка до мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу для дослідження молекулярно-генетичним методом (Xpert MTB/RIF) за територіальним принципом (Додаток 4).

1.5. Оцінку, відповідно до Показань до госпіталізації пацієнтів із захворюванням на ТБ (Додаток 5); за наявності показань – скерування пацієнтів з підтвердженим ТБ для стаціонарного лікування.

1.6. Дотримання під час транспортування, надання медичної допомоги, догляду за хворим на ТБ заходів захисту від інфікування *M. Tuberculosis* (Додаток 6), відповідно до вимог наказу МОЗ України від 03.08.2020 № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами», а також із дотриманням вимог інфекційного контролю за ТБ визначених наказом МОЗ України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

1.7. Реєстрацію та сповіщення про виявлений випадок ТБ у відповідності до Порядку епідеміологічного нагляду за ТБ, затвердженого наказом МОЗ України від 09.03.2021 № 406 «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом та Зміни до критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації».

1.8. Забезпечити роботу по обстеженню контактних із хворим на підтверджений діагноз туберкульозу осіб, з метою виявлення у них ЛТБІ і призначення профілактичного лікування на рівні ЗОЗ первинної ланки.

1.9. Забезпечити на рівні ЗОЗ, ЦПМСД формування і роботу в групах ризику щодо виявлення активного туберкульозу, та ЛТБІ, а також своєчасне скерування пацієнтів з підозрою на туберкульоз всіх локалізацій на прийом до районного фтизіатра.

2. Генеральному директору Центру легеневого здоров'я Раку Л.М. забезпечити організацію:

2.1. Надання організаційно-методичної допомоги надавачам медичних послуг з питань діагностики та лікування пацієнтів з туберкульозом.

2.2. Планування та управління запасами лікарських засобів для лікування ТБ, в тому числі організація та забезпечення логістики, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог нормативних документів.

2.3. Ведення обліково-звітної документації щодо ведення випадку туберкульозу.

2.4. Консультування, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з ТБ, у межах компетенції, відповідно до національного Стандарту охорони здоров'я при туберкульозі та за територіальним принципом.

2.5. Взаємодію з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

2.6. Створити на базі Центру Легеневого Здоров'я та затвердити склад Обласної Лікарської Комісії для розгляду всіх деструктивних і запущених форм туберкульозу у пацієнтів.

2.7. Щоквартально розглядати всі випадки на комісії всі випадки деструктивних і запущених форм туберкульозу у пацієнтів із залученням представників первинної медичної допомоги та ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ЛІТВІНСЬКА

Верес М.М.
Рак Л.М.

Додаток 1
до наказу ДОЗ ЛОДА
від _____ № _____

Скринінгова анкета
для дорослої особи стосовно чинників ризику та
симптомів, що можуть свідчити про ТБ*
(відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.2023 р. № 102
«Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами))

№ п/п	Запитання	Так	Ні
Симптоми, що можуть свідчити про туберкульоз, для дорослої людини			
1.	Чи є у Вас кашель або покашлювання більше 2-х тижнів?		
2.	Чи помітили Ви останнім часом підвищену втомлюваність та слабкість?		
3.	Чи є у Вас підвищена пітливість, особливо вночі?		
4.	Чи зменшилась вага Вашого тіла з невизначених причин?		
5.	Чи є у Вас упродовж останнього часу підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення – до 37-37,2°C)?		
6.	Чи є у Вас задишка при незначному фізичному навантаженні?		
7.	Чи турбує Вас біль в грудній клітці?		
Чинники ризику			
8.	Чи хворіли Ви на туберкульоз в минулому?		
9.	Чи є у Вас хронічне захворювання, що призводить до зниження імунітету (ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, онкологічні захворювання тощо)?		
10.	Чи отримуєте Ви лікування преднізолоном, або іншими препаратами, які впливають на імунітет (зазвичай, застосовуються при лікуванні злоякісних новоутворень, бронхіальної астми, ревматоїдного артрити тощо)		
11.	Чи проводилася Вам трансплантація органів (кісткового мозку)?		
12.	Чи мали Ви контакт із хворим на туберкульоз за останні два роки?		
13.	Чи перебували Ви в місцях позбавлення волі впродовж останніх 2-х років?		
14.	Чи характерне для Вашого життя хоча б одне забезпечення родини, міграція, вживання алкоголю та наркотичних речовин, безпритульність?		
*обстеження з метою виявлення туберкульозу проводиться за відповіді «так» на будь-яке запитання			

**Скринінгова анкета для батьків або законних представників
дитинистосовно чинників ризику та симптомів, що можуть
свідчити про ТБ у дитини та підлітка**

(відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.2023 р. № 102

«Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами)

№ п/п	Запитання	Так	Ні
Симптоми, що можуть свідчити про туберкульоз			
1.	Чи є у Вашої дитини кашель або покашлювання більше 2-х тижнів?		
2.	Чи помітили Ви останнім часом підвищену втомлюваність та слабкість, або навпаки збудженість дитини, втрату інтересу до ігор та звичайних занять?		
3.	Чи помітили Ви підвищену пітливість дитини, особливо вночі?		
5.	Чи є у дитини впродовж останнього часу підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення – до 37-37,2 °C)?		
6.	Чи реагує дитина на фізичні навантаження, так саме як раніше? Чи з'явилася задишка навіть при незначному фізичному навантаженні?		
7.	Чи скаржилася дитина на біль в грудній клітці?		
8.	Чи уповільнився ріст та зростання маси тіла у дитини в останні місяці?		
Чинники ризику			
9.	Чи перебувала дитина в контакті з хворим на туберкульоз за останні два роки?		
10.	Чи хворіла дитина/підліток на туберкульоз у минулому?		
11.	Чи є в дитини/підлітка хронічне захворювання, що призводить до зниження імунітету (ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, бронхіальна астма, онкологічні захворювання, вроджений імунodefіцитний стан тощо)?		
12.	Чи проводилася дитині трансплантація органів (кісткового мозку)?		
13.	Чи отримує дитина упродовж більш ніж 1 місяця лікування преднізолоном, або іншими препаратами, які впливають на імунітет (зазвичай, застосовуються при лікуванні злоякісних новоутворень, бронхіальної астми, ревматоїдного артрити тощо)?		
14.	Чи зазнала сім'я дитини несприятливих соціальних впливів: низький рівень матеріального забезпечення родини, міграція, вживання алкоголю та наркотичних речовин дитиною або батьками, безпритульність?		
*обстеження з метою виявлення туберкульозу проводиться за відповіді “так” на будь-якезапитання Під час опитування важливо зібрати анамнез життя дитини, що може вплинути на прийняття клінічного рішення, зокрема, чи отримала дитина вакцинацію БЦЖ, чи проходила дитина обстеження на ВІЛ-інфекцію, ВІЛ-статус матері дитини тощо			

**Перелік симптомів та захворювань,
за наявності яких пацієнту проводять обстеження на ТБ,
фактори ризику захворювання на ТБ**
(відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.2023 р. № 102
«Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами))

I. Симптоми, при яких пацієнту проводять обстеження на ТБ в закладах охорони здоров'я незалежно від підпорядкованості та рівня надання медичної допомоги:

1. Обстеження з метою **виявлення ТБ легень** проводиться за наявності таких симптомів:

- 1) кашель більше 2-х тижнів;
- 2) кровохаркання;
- 3) підвищена втомлюваність та слабкість;
- 4) підвищена пітливість, особливо вночі;
- 5) зменшення ваги тіла з невизначених причин;
- 6) підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення – до 37 – 37,2°C);
- 7) задишка при незначному фізичному навантаженні;
- 8) біль у грудній клітці.

2. Обстеження з метою **виявлення позалегеневого ТБ** проводиться за наявності таких симптомів:

- 1) тривалий біль у хребті та великих суглобах нез'ясованої етіології;
- 2) збільшення периферичних лімфатичних вузлів нез'ясованої етіології;
- 3) хронічне захворювання нирок і сечовивідних шляхів;
- 4) безпліддя у жінок і чоловіків нез'ясованої етіології;
- 5) увеїт.

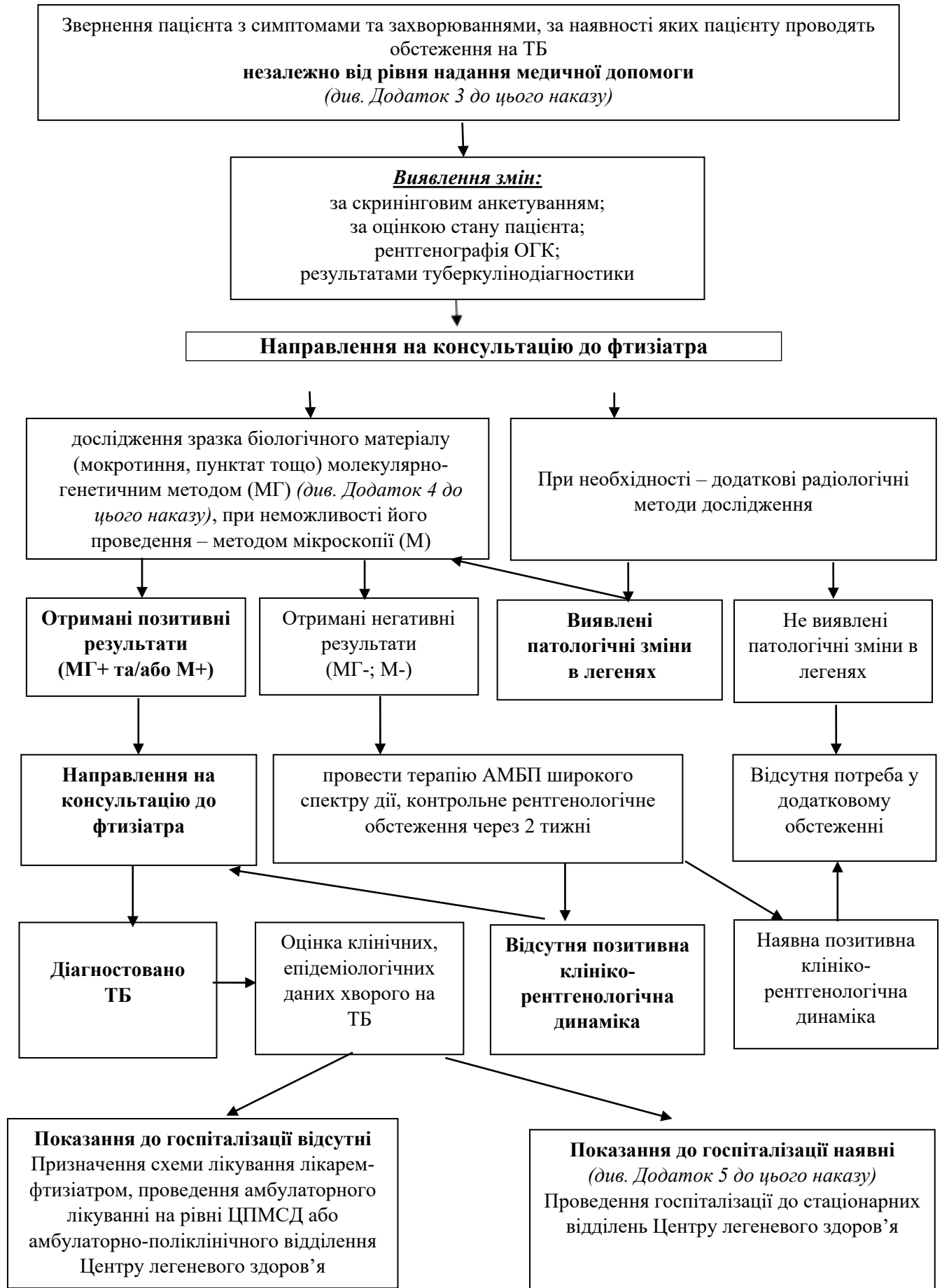
За клінічними показаннями можуть обстежуватися також пацієнти з тривалими запальними процесами іншої локалізації, резистентними до лікування, що проводиться, а також при виявленні змін, що можуть свідчити про ТБ за результатами обстеження.

II. До груп ризику розвитку ТБ належать:

- 1) діти і дорослі, які мали близький або осередковий контакт з хворим на ТБ;
- 2) діти і дорослі, які живуть з ВІЛ;
- 3) особи, які працюють або працювали в минулому у виробничих умовах із впливом діоксиду кремнію (головним чином, шахтарі і працівники металургічної галузі);
- 4) особи, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання; особи, узяті під варту, або засудженні до позбавлення волі, які перебувають в слідчих ізоляторах/установах виконання покарань; особи, які звільнилися із місць позбавлення волі; персонал, в т.ч. медичний, слідчих ізоляторів та установ виконання покарань;

- 5) медичні працівники;
- 6) особи з вперше виявленими фіброзними залишковими змінами в легенях, які не отримували лікування від ТБ;
- 7) діти і дорослі з захворюваннями, що призводять до ослаблення імунітету (хворі із злоякісними новоутвореннями, цукровим діабетом, пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію, терапію інгібітором ФНП- α);
- 8) особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики;
- 9) мігранти, в тому числі, внутрішньо переміщені особи;
- 10) військовослужбовці;
- 11) особи, які перебувають за межею бідності (зокрема, особи, які перебувають на обліку як малозабезпечені);
- 12) особи без визначеного місця проживання;
- 13) особи, які раніше лікувались від ТБ;
- 14) особи з хронічними респіраторними захворюваннями;
- 15) особи із захворюванням на пневмонію;
- 16) курці;
- 17) особи із дефіцитом харчування або особи з індексом маси тіла ≤ 18 ;
- 18) особи із гастректомією або шлунково-кишковим шунтуванням;
- 19) особи із хронічною нирковою недостатністю;
- 20) особи віком старше 60 років;
- 21) вагітні (а також післяпологовий період протягом 3 місяців);
- 22) особи, які перебувають у закладах охорони здоров'я психоневрологічного профілю;
- 23) особи, які живуть у притулках.

РЕГІОНАЛЬНИЙ МАРШРУТ ПАЦІЄНТА З ПІДОЗРОЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ



Додаток 4
до наказу ДОЗ ЛОДА
від _____ № _____

Заклади, що здійснюють молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз (Xpert MTB/RIF) за територіальним принципом

№ з/п	Заклад, де інстальований Xpert MTB/RIF	Територія проживання пацієнта	Примітки
1	КНП БМР «Буська центральна районна лікарня»	Бродівська ОТГ Буська ОТГ Заболотцівська ОТГ Красненська ОТГ Підкаміньська ОТГ	
2	КНП «Золочівська центральна районна лікарня» ЗМЛ Золочівського району Львівської області	Золочівська ОТГ Поморянська ОТГ	
3	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради»	Бісковицька ОТГ Добромільська ОТГ Новокалінівська ОТГ Ралівська ОТГ Рудківська ОТГ Самбірська ОТГ Старосамбірська ОТГ Стрілківська ОТГ Хирівська ОТГ	
4	КНП «Турківський центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради»	Боринська ОТГ Турківська ОТГ	
5	КНП «Мостиська міська лікарня» ММР Львівської області	Мостиська ОТГ Судовишнянська ОТГ Шегинівська ОТГ Великолюбінська ОТГ Городоцька ОТГ Комарнівська ОТГ	
6	КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» НМР	Івано-Франківська ОТГ Новояворівська ОТГ Рава-Руська ОТГ Яворівська ОТГ	
7	КНП СМР «Стрийська центральна районна лікарня»	Гніздичівська ОТГ Грабовецько-Дулібівська ОТГ Жидачівська ОТГ Журавненська ОТГ Козівська ОТГ Моршинська ОТГ Новороздільська ОТГ Розвадівська ОТГ Сколівська ОТГ Славська ОТГ Стрийська ОТГ Ходорівська ОТГ	

8	КНП «6-а міська поліклініка м. Львова»	Львівська ОТГ	
9	КНП «Дрогобицька міська поліклініка	Бориславська ОТГ Дрогобицька ОТГ Меденицька ОТГ Східницька ОТГ Трускавецька ОТГ	
10	КНП ЦПМСД Шептицької міської ради	Белзька ОТГ Великомостівська ОТГ Добротвірська ОТГ Лопатинська ОТГ Радехівська ОТГ Сокальська ОТГ Червоноградська ОТГ	
11	Бактеріологічна лабораторія КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»	Бібрська ОТГ Глинянська ОТГ Давидівська ОТГ Добросинсько-Магерівська ОТГ Жовківська ОТГ Жовтанецька ОТГ Зимноводівська ОТГ Кам'янка-Бузька ОТГ Куликівська ОТГ Миколаївська ОТГ Мурованська ОТГ Новояричівська ОТГ Оброшинська ОТГ Перемишлянська ОТГ Підберізцівська ОТГ Пустомитівська ОТГ Сокільницька ОТГ Солонківська ОТГ Тростянецька ОТГ Щирецька ОТГ	

Показання до госпіталізації пацієнтів із захворюванням на туберкульоз

(відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.2023 р. № 102

«Про затвердження стандартів охорони здоров'я при туберкульозі» (зі змінами)

1. Ускладнені форми ТБ, що потребують стаціонарного лікування:
 - легенева кровотеча;
 - кровохаркання;
 - спонтанний пневмоторакс;
 - емпієма плеври;
 - інші ускладнення легеневого та/або позалегеневого ТБ, що потребують інтенсивного надання медичної допомоги та (або) постійного цілодобового медичного спостереження.
2. Тяжкий клінічний стан хворого¹, зокрема:
 - лихоманка, що супроводжується підйомами температури вище 38°C, дихальна недостатність II-III ступенів;
 - серцева недостатність III-IV функціональних класів;
 - різке зниження ваги – кахексія (показник індексу маси тіла нижчий за 16).
3. Стан, пов'язаний із супутнім захворюванням, що виникло/загострилося на тлі ТБ, становить загрозу для життя та/або здоров'я пацієнта і не підлягає лікуванню в амбулаторних умовах.
4. Виражені побічні реакції на протитуберкульозні препарати, усунення яких неможливо в амбулаторних умовах, до моменту їх ліквідації. Тяжкі побічні реакції на лікування – до стабілізації стану.
5. Хірургічне лікування при неефективності консервативного лікування, строк госпіталізації не може перевищувати потребу в післяопераційному догляді.
6. Легеневий ТБ з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії, за неможливості забезпечити ефективне та безпечне лікування в амбулаторних умовах – на перші 2-3 тижні з моменту призначення ефективної схеми лікування, що підтверджується даними гТМЧ/фТМЧ МБТ.
7. Примусова госпіталізація хворих на заразні форми ТБ за рішенням суду відповідно до статті 11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» як виняток у разі, якщо використані/вичерпані інші підходи для забезпечення безперервного лікування хворого.

¹ рекомендовано використання методик, що дозволяють проводити оцінку загального стану пацієнта в процесі лікування, наприклад, Індекс Карновського або шкала ВООЗ- ECOG

**Заходи захисту від інфікування *M. Tuberculosis* під час транспортування,
надання медичної допомоги, догляду за хворим на ТБ**
(відповідно до наказу МОЗ України від 03.08.2020 р. № 1777
«Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування
при проведенні догляду за пацієнтами»)

Вид заходу захисту	Тривалість дотримання заходу захисту	Примітки
<i>Туберкульоз легень або туберкульозний ларингіт не підтверджений</i>		
Повітряні + стандартні		Повітряні заходи захисту дозволено припинити у випадках: 1. туберкульоз легень з бактеріовиділенням малої ймовірності та 2. встановлено клінічний діагноз, який пояснює симптоматику у хворого або 3. результати 3 бактеріоскопічних досліджень мокроти негативні (кожен із зразків мокроти має бути взятий з інтервалом 8-24 годин і мінімум один з них вранці (до 8 години ранку).
<i>Туберкульоз легень або туберкульозний ларингіт підтверджений</i>		
Повітряні + стандартні		Повітряні заходи захисту слід реалізовувати до отримання 3 негативних (взятих послідовно, але не більше одного за день) бактеріоскопічних досліджень мокроти, за умови що хворий знаходиться на протитуберкульозній терапії.
<i>Туберкульоз позалегеневий без дренажного вогнища, менінгіт</i>		
Стандартні		Обстежте хворого на туберкульоз легень.
<i>Туберкульоз позалегеневий з дренажним вогнищем або при внутрішньобронхіальному розкритті каверни</i>		
Повітряні + контактні + стандартні		Обстежте хворого на туберкульоз легень. Повітряні і контактні заходи захисту слід реалізовувати до закриття дренажу або каверни - отримання 3 негативних (взятих щоденно протягом 3 днів) бактеріоскопічних досліджень виділень з дренажу або мокротиння.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

1. Заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, засновані на недопущенні інфікування, включають:

1) обмеження безпідставного транспортування - транспортування пацієнтів, які можуть бути джерелом інфекції, має застосовуватися виключно у випадках необхідності обстеження або проведення медичних процедур, що не можуть бути виконані в палаті/кімнаті;

2) під час транспортування слід використовувати бар'єрні заходи недопущення інфікування (наприклад, маски, халат захисний від інфекційних агентів (ХЗІА), накладення непроникних пов'язок на уражені ділянки шкіри або на шкіру місця дренирування);

3) заклад охорони здоров'я (ЗОЗ) або окремих підрозділ ЗОЗ, в який транспортується пацієнт, має бути поінформований щодо заходів попередження інфікування;

4) бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД), яка здійснює транспортування, має бути попереджена щодо необхідних заходів недопущення інфікування.

2. Заходи з профілактики зараження працівників ТБ при транспортуванні пацієнта з підозрюваним або підтвердженим ТБ, в спеціалізованому і спеціальному санітарному транспорті включають:

1) пацієнт має бути одягнений в маску протягом всього періоду транспортування;

2) члени бригади ЕМД мають бути одягнені в респіратор класу захисту не нижче FFP2;

3) вентиляційна система в режимі рециркуляції може використовуватися лише при використанні хепа-фільтрів;

4) за можливості, кабіну водія/пілота слід ізолювати, при цьому необхідно забезпечити якомога більше надходження повітря в зону пацієнта (наприклад, шляхом встановлення вентиляційних решіток в автомобілі ЕМД);

5) в разі неможливості ізолювати кабіну водія автомобіля ЕМД, повітряний потік має бути налаштований таким чином, аби повітря потрапляло через кабіну, проходило через зону пацієнта (над ним) і виходило через вентиляційну решітку в задній частині автомобіля;

6) в разі неможливості ізолювати кабіну автомобіля ЕМД та інших видів спеціалізованого і спеціального санітарного транспорту, водій/пілот має бути одягнений в респіратор класу захисту не нижче FFP2.

ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ

I. Стандартні заходи захисту включають:

- 1) гігієна рук;
- 2) використання рукавичок в залежності від методів надання допомоги;
- 3) використання ХЗІА в залежності від методів надання допомоги;
- 4) респіраторна гігієна і гігієна кашлю, використання масок в залежності від методів надання допомоги;
- 5) використання захисних окулярів або щитків в залежності від методів надання допомоги;
- 6) безпека при виконанні ін'єкцій;
- 7) використання чистого і безпечного обладнання та інструментарію для надання медичної допомоги;
- 8) утилізація відходів;
- 9) очищення приміщень;
- 10) використання чистої і безпечної білизни.

II. Повітряні заходи захисту включають:

- 1) навчання і підготовку щодо використання респіраторів (показання до носіння, проведення якісного тесту на прилягання до обличчя (фіт тестування), відпрацювання практичних навичок з надягання, знімання, зберігання та утилізації респіратора);
- 2) планову вакцинацію працівників ЗОЗ, які можуть бути задіяними в наданні допомоги пацієнтам з аерогенною інфекцією, в разі невизначального або низького титру антитіл до вакцинованих інфекційних хвороб з повітряним шляхом інфікування (IgG до Measles morbillivirus та IgG до varicella-zoster virus);
- 3) навчання і підготовку щодо експлуатації палат ізоляції пацієнтів з аерогенною інфекцією (ПППІ);
- 4) навчання і підготовку пацієнтів щодо етикету кашлю і респіраторної гігієни;
- 5) навчання і підготовку щодо правил транспортування пацієнтів з аерогенною інфекцією.

III. Контактні заходи захисту включають:

- 1) надягання одягу, уніформи, лабораторних та халатів захисту від інфекційних агентів;
- 2) надягання рукавичок;
- 3) надягання окулярів.